干眼患者睑缘管理

2025版／2026刊载 · 正面

① 评估与分型

所有干眼均评估睑缘：先结构异常，再后部疾病，最后前部睑缘；脂溢性/螨虫性/葡萄球菌性/MGD可并存。优先照相与腺体红外显影。

2025版/2026刊 p106–107

② 居家清洁

推荐0.01%次氯酸或清洁液/湿巾；葡萄球菌性用前者，脂溢性/MGD去油脂。早晚各1次，持续1个月以上。

2025版/2026刊 p108

③ 热敷与冷敷

MGD热敷40~45 ℃，每次10 min以上，每日至少1次、建议2周以上。重炎症冷敷约10 ℃、5~10 min，控制后可改热敷。

2025版/2026刊 p108

④ 螨虫性睑缘炎

含茶树油/4-松油醇等眼部湿巾，每日2次，一般2~3个月。兼看症状、体征、虫数；不得仅以虫数减少作为疗效或停治指标。

2025版/2026刊 p108

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

干眼患者睑缘管理

2025版／2026刊载 · 背面

⑤ 何时加院内治疗

居家效果不佳、依从性差或中重度：个体化加院内。按摩每周1次、1个月以上；深度清洁每1~2周1次，至分泌物明显减少。

2025版/2026刊 p107–109

⑥ 联合顺序与安全

先IPL后按摩/热液脉动，继续居家。囊肿按摩避开病灶；勿压眼球，青光眼谨慎。器械按摩不建议自行居家操作。

2025版/2026刊 p108–109

⑦ 药物与结构异常

细菌感染局部敏感抗生素；难治或全身病可考虑口服抗生素，剂量疗程未明确。无效MGD考虑探通；缺损修补、闭合不全必要时手术。

2025版/2026刊 p109

⑧ 复评与特殊人群

复评症状、睑缘、腺口和睑酯。统一复诊间隔/停治阈值，儿童及孕哺期专门方案、完整禁忌清单：原文未明确。

2025版/2026刊 p108–109